



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صابره عبدالفتاح عبدالمجيد عبد المطلب

العنوان : ممممممممم

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة

رقم البطاقة : 28301091400923 رقم التليفون : 01050699628 تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 09-01-1983 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صابره عبدالفتاح عبدالمجيد عبد المطلب National ID: 28301091400923	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

صاير

عبد الفتاح عبد المجيد عبد المطلب

١٩ اش النور سليمان مزرعة النضيم

شبرا الخيمة - القليوبية

١٩٨٣/٠٨/٠٩

٢٨٣.٠١.٩١٥.٠٩٢٣

KD4556591



٢٠٢٣/٠٨ ٢٨٣.٠١.٩١٥.٠٩٢٣

حاصلة على ليسانس دراسات إقليمية

علم تاريخ

مسلمة

أنثى



البطاقة مارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/٣٠

١١



٩٦

EVIDT FORM

11/2/2022

Name	صابر ج. لفتاح ج. الجي	MRN	877- / 0.01
Age	38	ID	512.1.914-902
Menopausal status	Pre	Phone	
OCP	+ve	marital status	widow
Co morbidity	SIP Rt. BCS & SLNB post-neoadj	Family history	-ve

Clinical Data

Bx	complete path response, 4 LNs
ER	8
PR	8
HER2	+3
Ki67	25

Sonomammography:

Awaiting post op t.t.t.

Mets Workup:

Recommendations:

in view of ET₂ - M₁ - TctHP K6cy

→ BCS, ALN → YPT₀ - YPN₀/4
PCR.

MDT OUTCOME & PLAN

in view of PCR

- To continue Herceptin + paclitaxel up to 17 cycles
- AI + Zoladex
- PCRT

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

10081901

Name: صابره عبد الفتاح عبد المجيد عبد المطلب		
MR. : 3910		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient underwent bilateral breast screening mammography (BSM) in July 2025, which demonstrated bilateral BIRADS 2 findings. A pelvic ultrasound (PAUS) performed in August 2025 identified a hemangioma (HFL) and was scheduled for follow-up. A bone scan was performed and was negative (Free). The patient was prescribed Zoladex and Femara on the day of the visit. The patient continues on Femara with supportive care and Zoladex, with the next clinic appointment scheduled for 28 September 2026.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	ندى حسن صلاح كامل	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Request No. : 130023
Request Date : 13/10/2021
Verification Date : 24/10/2021
Financial Category : اوزام دار السلام - نفقة النولة
Department : Out Patient
IHC No. :

Patient Name : الأستاذة / صابرة عبدالفتاح عبدالعجيد عبدالعظيم	Request No. : 13005761
Patient No. : 28301091400923	Request Date : 05/07/2022
Ref No. : 1933/22	Verification Date : 23/07/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة السلام - اوراداد السلام
Age : 39 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass post NACT

Nature of the specimen: Right WLE & Right SLN biopsy

Gross Examination:

Procedure: Right WLE specimen measured 7x3x1.5 cm with covering skin ellipse measured 2x0.5 cm .

Tumor extent : ill defined tumor bed site 6x3x1.5 cm

Skin involvement: Free

Distance from margins: (Undesignated margins)

Distance from skin , 0.2 from deep margin

Lymph nodes number and size: 4 SLNs , largest 1x1 cm

Frozen section: Free SLNs (0/4)

Microscopic examination:

Histological type: No residual of tumour tissue detected

Skin involvement: Free

Lymph node involvement: Free L.Ns (0/4)

Resection Margins: Free margins

Histologic response to therapy: Pathologic complete response

Diagnosis:

Right WLE & SLN biopsy (post NACT):

Residual viable tumor in a previously diagnosed invasive duct carcinoma

Free margins

Free SLNs (0/3)

Pathologic complete response (PCR)

Stage : ypT0 , ypN0

Prof. Dr. Gamal Abdelatty

Dr.Samah Sayed

Verified by :

Samah sayed

Date : 24/07/2022 13:55:00

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



Patient Name: Sabra Abdel Fattah Abdel Maguid Abdel Mottaleb	Date : 07/09/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 467/2021	Pat. ID: 12559

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

↓ Reported case of right breast cancer.

I Chest:-

- *As compared to 2/7/2022, The current revealed:*
- *Newly developped* Right apical and right upper lobar lateral segments subpleural reticulations, Likley Post radiation sequel for clinical correlation.
- Otherwsie no sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Few prominent subcentimeteric right axillary lymph nodes level I and II groups.
- No hilar or mediastinal pathologically enlarged lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

Reviewing previous study report dated 24/11/2021. No available previous study images. The current study shows;

- The liver is seen mildly to modetarely with diffuse homogenous low parenchymal CT attenuation. No definte focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

- Bilateral sacro-iliitis.
- Multi-level hemangiomata noted at D3, D6, D10 and D12 vertebrae.



Patient Name: Sabra Abdel Fattah Abdel Maguid Abdel Mottaleb	Date : 07/09/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 467/2021	Pat. ID: 12559

- Multiple sclerotic foci are noted at D8, L3, right pedicle of D12 and sternal body
- Small lytic lesion is noted at L4 vertebra.

Opinion:

Right breast cancer showing;

- Multiple sclerotic and lytic osseous lesions as described for bone scan assesemen
- No evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits.

Dr. Shaimaa Khaled, MSc.

Dr. Walid Mohamed, MD

19/09/2024 02:42 م

Name : Sabra Abdul Fattah Abdul Mageed

Date : 24/11/2021

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

A case with history of right sided breast cancer.

1. Chest:

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- Few prominent level I & II right axillary lymph nodes are seen with largest measuring 1.5x1cm (at level I).
- No evidence of pleural effusion or masses.
- Normal cardiac size.
- No pericardial effusion detected.
- D3, D6 and D11 osseous hemangiomata.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is of average size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries. No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- The spleen is of average size with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No pelvi-abdominal collections.
- L3 and sternal body sclerotic foci.

OPINION:

- **Prominent right axillary lymph nodes.**
- **D3, D6 and D11 osseous hemangiomata**
- **L3 and sternal body sclerotic foci for bone scan evaluation.**
- **No distant neoplastic lesions could be detected.**

Much Obligated,

Dr. Sherif Sameh, M.D.

Dr. M. Gomaa, M.D.

MM/SABRA ABD ALFATTAH ABD ALMGDID	PATIENT ID: 1191826
DEAR SIR	STUDY DATE: 14/10/2024

Tc^{99m} MDP DUAL PHASE SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

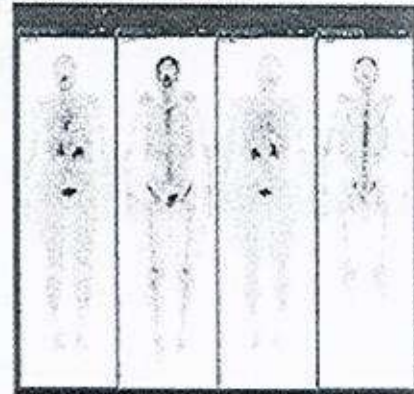
- 41-year-old female patient, who gave history of treated right breast cancer in 2022 and referred for status evaluation and metastatic work up.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired at 5 minutes and 2 hours post I.V injection of the tracer.

Findings

- The skeleton is free from any abnormal active or cold foci that would account for metastatic deposits or other serious lesions.
- Degenerative changes are noticed at multiple levels of the spine and around big joints.
- The early blood pool scan is unremarkable.



IMPRESSION

The skeleton is free from metastatic lesions on scintigraphic basis.

Much Obligated,
Dr. Alaa Nagi, MD,
Nuclear Medicine

(Handwritten signature)



Presidential Program for Women's health

Name: SABRA ABD EL FATAH ABDEL MEGID

Date: 29/08/2021

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary right UOQ palpable lump

Technique

Mediolateral oblique and CC views

High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR category B)
- Right upper UOQ irregular mass with partially obscured margin and internal microcalcification.
- Ultrasound demonstrated
- 9 o'clock non circumscribed hypoechoic mass lesion with spiculated margin and internal microcalcifications, it measures 13 x 22 mm being 3.5 away from nipple (corresponding to the palpable lump)
- No cystic lesions
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Pathologically enlarged single lymph nodes is noted measuring 15 x 10 mm showing cortical thickening measuring 5 mm ,with abutted, eccentric compressed hilum.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR category B)
- No masses, or asymmetric densities , or distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated:
- 2 well circumscribed hypoechoic mass lesions are noted ,one of them is rounded at 12 o'clock measuring 7 mm in diameter, and the other is oval at 5 o'clock measuring 12 x 5 mm with no vascularity detected.
- No cystic lesions
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs .

Conclusion:

Right breast: UOQ malignant looking mass lesion with accompanying right axillary single pathological lymph node (BIRADS5) , biopsy is performed in today's setting.

Left breast: 2 likely benign mass lesions as described , fibroadenomas(BIRADS3)

Best Regard

Dr. Eman Elmaraghi, Dr Amira Abdel salam

Dr. Iman Adel

Breast Imaging Consultant
& Breast Intervention